Çıkmış Sorular 2026–2027

Derleme PDF'i ve “Konu çalışma grubu” tartışması (23.10 10:00 – 24.10 15:25) birleştirildi.

91	9	14
toplanan / 100	toplanmadı	kısmi / üretilmiş

Sınav sırası: Genetik 1–12 · Enfeksiyon 13–34 · Patoloji 35–68 · Halk Sağlığı 69–78 · Üroloji 79–90 · Kadın Doğum 91–96 · Farmakoloji 97–100

[YERİ TAHMİNİ]	Grupta numarası yazılmadı; dersin boş numarasına kondu.
[KISMİ]	Yalnız konu ya da doğru cevap hatırlanıyor, şıklar yok.
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]	Eksik şıklar ders notundan, hocanın soru üslubuyla üretildi.
[TARTIŞMALI]	Cevap öğrenciler arasında kesinleşmedi; nota bakın.

Tıbbi Genetik

Soru 1–12
12/12 toplandı

1. Aşağıdakilerden hangisi bir minör anomali örneği değildir?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Epikantus katlantısı
B) Düşük kulak
C) Clinodactyly (serçe parmağın içe kıvrılması)
D) Yarık damak
E) Tek palmar çizgi (Simian çizgisi)

2. Bebeğin kedi miyavlamasına benzer ağlaması, mikrosefali ve hipotoni ile karakterize olan ve 5. kromozomun kısa kolundaki delesyon (5p-) sonucu gelişen sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cri du Chat sendromu
B) Wolf-Hirschhorn sendromu
C) Down sendromu
D) Patau sendromu
E) Edwards sendromu

3. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) endikasyonları değerlendirildiğinde, aşağıdaki durumlardan hangisinde PGT yapılmasına gerek yoktur?

[YERİ TAHMİNİ]

A) İleri anne yaşı
B) Tekrarlayan tüp bebek (IVF) başarısızlıkları
C) Çiftlerden birinde dengeli kromozomal translokasyon varlığı
D) Fetal Down sendromu taramasında ikili testin düşük riskli çıkması
E) Tek gen hastalığı taşıyıcısı çiftler

4. Ultrasonografide ense saydamlığı (NT) artışı saptanan bir fetüste, sitogenetik incelemede aşağıdaki karyotiplerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Down sendromu
B) Edwards sendromu
C) Patau sendromu
D) Klinefelter sendromu
E) Turner sendromu

5. 46, XX karyotipine sahip bir yenidoğanda 21-hidroksilaz enzim eksikliği saptanmıştır. Bu klinik tablo aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH)
B) Androjen Duyarsızlığı Sendromu
C) 5-alfa Redüktaz Eksikliği
D) Swyer Sendromu
E) Turner Sendromu

6. Kadın cinsiyet organlarının ve overlerin embriyonik gelişim basamaklarında anahtar rol oynayan ve Wnt/β-katenin yolaklarını aktive eden genler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) SRY ve SOX9
B) WNT4 ve DAX1
C) WT1 ve SF1
D) AMH ve AR
E) AZF ve KDM5D

7. BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu taşıyan over ve meme kanserli hastalarda homolog rekombinasyon DNA tamir mekanizması bozuktur. Bu hastalarda sentetik ölümcül etki oluşturarak tedavide kullanılan hedefe yönelik ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) PARP inhibitörleri
B) Tirozin kinaz inhibitörleri
C) EGFR monoklonal antikorları
D) Proteazom inhibitörleri
E) mTOR inhibitörleri

8. Serumda Alfa-Fetoprotein (AFP), Beta-hCG ve Laktat Dehidrojenaz (LDH) tümör belirteçlerinin birlikte yükselmesi aşağıdaki kanser türlerinden hangisinin tanısı ve takibi için karakteristiktir?

A) Mesane kanseri
B) Prostat kanseri
C) Over epitelyal kanseri
D) Testis germ hücreli tümörleri
E) Endometriyum karsinomu

9. Prenatal tanı yöntemleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Amniyosentez genellikle 15-20. gebelik haftaları arasında uygulanır.
II. Kordosentez fetal kan örneklemesi sağlar.
III. CVS en erken invaziv yöntemdir.
[YERİ TAHMİNİ]

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Preimplantasyon genetik tanıda embriyonun kendisine dokunulmadan uygulanabilen ancak sadece maternal mayoz bölünme hatalarını yansıtabilen; paternal genetik katkıyı ve fetal cinsiyeti göstermeyen biyopsi tekniği hangisidir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Polar Body (Kutup Cisimciği) Biyopsisi
B) Gün 3 Blastomer Biyopsisi
C) Gün 5-6 Trofektoderm Biyopsisi
D) İç Hücre Kitlesi (ICM) Biyopsisi
E) Koryon Villus Biyopsisi (CVS)

Not Grupta paylaşılan ekran görüntüsünde bu soru "Soru 3" olarak görünüyor; numarası kesin değil.

11. Başlangıçta normal gelişen bir yapının mekanik kuvvetlerin etkisiyle şeklinin veya konumunun değişmesine deformasyon denir. Aşağıdakilerden hangisi amniyotik bandın yaptığı mekanik basılardan kaynaklı oluşan deformasyona örnektir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Yarık dudak ve damak
B) Amniyotik bantlara bağlı ekstremite kaybı
C) Akondroplazi
D) Rahim içi basıya bağlı kraniyofasiyal şekil bozukluğu
E) Nöral tüpün kapanmamasına bağlı spina bifida

Not Grupta 24.10 eklendi (TBG). Kök birebir değil, şıklar öğrencilerce doğrulandı. A ve E malformasyon, B disrupsiyon, C displazi.

12. Erken prenatal tanıda uygulanan koryon villus örneklemesinde (CVS) genetik analiz için alınan hücrelerin embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Fetal amniyotik kavite epitel döküntüleri (amniyositler)
B) Koryon frondozum (trofoblastik villus hücreleri)
C) Fetal umbilikal kordon Wharton jölesi mezenkimi
D) Maternal uterin desidua bazalis hücreleri
E) Fetal karaciğer hematopoetik blast hücreleri

Not Grupta tek öğrenci "böyle bir soru vardı" dedi; kök ve şıklar paylaşılan ekran görüntüsünden, kesin değil.

Enfeksiyon Hastalıkları

Soru 13–34
19/22 toplandı

13. Toxoplasma gondii enfeksiyonu ve korunma yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Seronegatif gebe kadınların ev kedisi ile temas etmemesi gerekir.
B) IgG avidite testi enfeksiyonun akut mu yoksa geçirilmiş mi olduğunu anlamada önemlidir.
C) Parazit insandan insana solunum yolu damlacıkları ile kolayca bulaşır.
D) Gebelikte geçirilen akut enfeksiyon fetüste hasar oluşturmaz.
E) Enfeksiyon kaynağı esas olarak kontamine süt ürünleridir.

14. Bakteriyel vajinozis tanısında kullanılan Amsel kriterleri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi bu kriterler arasında yer almaz?

A) Vajinal pH değerinin > 4,5 olması
B) Direkt mikroskopide "clue cell" görülmesi
C) Whiff (amin) testinin pozitif olması (%10 KOH ile balık kokusu)
D) Direkt mikroskopide büyük büyütme alanında >10 lökosit/LÖA (PML) görülmesi
E) İnce, homojen gri-beyaz vajinal akıntı varlığı

15. Beta-laktam direnci ve antibiyotik tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
[YERİ TAHMİNİ]

A) GSBL üreten suşlarda karbapenem grubu antibiyotikler tercih edilir.
B) MRSA enfeksiyonlarında vankomisin kullanılabilir.
C) GSBL üreten gram-negatif basiller 1. ve 2. kuşak sefalosporinlerle güvenle tedavi edilebilir.
D) Beta-laktamaz inhibitörleri (örn. klavulanik asit) enzimatik yıkımı engeller.
E) Pseudomonas enfeksiyonlarında antipseudomonal beta-laktamlar tercih edilmelidir.

16. Sağlıklı insanlarda steril olan ve normal florada mikroorganizma bulunmayan vücut bölgesi/sıvısı aşağıdakilerden hangisidir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Cilt yüzeyi
B) Kolon
C) Beyin omurilik sıvısı (BOS)
D) Ağız boşluğu
E) Dış üretra

Not Grupta "Flora hangisinde bulunmaz? → BOS" olarak doğrulandı.

17. HBsAg pozitif olduğu bilinen bir hastanın kanı ile iğne batması sonucu temas eden ve daha önce hiç aşılanmamış bir sağlık çalışanına uygulanacak en uygun koruyucu profilaksi yaklaşımı hangisidir?

A) Sadece 1 doz hepatit B aşısı yapılması yeterlidir.
B) Yalnızca HBIG uygulanmalı, aşı yapılmamalıdır.
C) En kısa sürede hem HBIG hem de ilk doz hepatit B aşısı eş zamanlı yapılmalıdır.
D) 6 ay süreyle oral antiviral tedavi başlanmalıdır.
E) Sadece izlem yapılır, tedaviye gerek yoktur.

18. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (CYBİ) korunmada bireysel ve toplumsal önlemler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan bir koruyucu önlem (birincil koruma) sayılmaz?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Bariyer yöntemlerinin (kondom) kullanımı
B) Güvenli cinsel davranış bilincinin geliştirilmesi
C) CYBİ olan kişinin tanı alıp derhal tedavi edilmesi
D) Risk altındaki grupta hepatit B ve HPV aşılamaları
E) Cinsel partner sayısının sınırlandırılması

19. Genel hastane enfeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri ile ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Sıçrama ihtimalinde önlük, eldiven, maske ve koruyucu gözlük takılmalıdır.
B) Temas izolasyonundaki odalara girerken önlük ve eldiven giyilmesi zorunludur.
C) Damlacık ve solunum yolu izolasyonundaki hastaların odasına girerken sadece kumaş hijyenik maske takılması yeterlidir.
D) Kontamine eller yıkanmadan başka hastaya temas edilmemelidir.
E) Kullanılmış enjektör iğneleri kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.

Not Grupta bu soru "İzolasyon yöntemleriyle (standart önlemler) ilgili hangisi yanlıştır?" diye de hatırlandı; o sürümde yanlış şık "Sıçrama ihtimali olan işlemlerde önlük ve eldiven tek başına yeterlidir". Bir öğrenci damlacık izolasyonunda taşıma sırasında hastaya cerrahi maske takıldığını da hatırladı.

20. Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi sekonder sifiliz evresinde görülen bulgulardan biri değildir?

A) Tabes dorsalis
B) El ve ayak tabanında makülopapüler döküntüler
C) Kondiloma lata
D) Yaygın lenfadenopati
E) Asemptomatik hepatit

21. Sifiliz hastalığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Birincil evrede görülen şankr tipik olarak ağrılı bir ülserdir.
B) Tedavide birinci basamak seçenek benzatin penisilin G'dir.
C) Latent evrede hastada belirgin bir klinik bulgu izlenmez.
D) Etkeni bir spiroket olan Treponema pallidum'dur.
E) Üçüncül evrede gommalar ve kardiyovasküler tutulumlar izlenebilir.

Not Bir öğrenci soruyu öncüllü hatırladı: "latent sifiliz...", "primer evrede şankr ağrılıdır", "kondiloma lata..." öncülleri vardı, diğer ikisi hatırlanmadı.

22. Klinik pratikte akılcı antibiyotik kullanımı ilkelerine göre doğru antibiyotik seçimi ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muhtemel mikroorganizmanın antimikrobiyal duyarlılık durumu bilinmelidir.
B) Kullanılacak antibiyotiğin PK/PD özellikleri bilinmelidir.
C) Enfeksiyon nedeni olan mikroorganizma bilinmeli veya tahmin edilmelidir.
D) Ateşi yüksek olan her hastaya odak bulunamasa dahi derhal geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.
E) İlacın organ toksisitesi değerlendirilmelidir.

23. HBsAg pozitif fakat aşı yapılmamış bir anneden doğan bebeğe doğumdan hemen sonra uygulanacak doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca hepatit B aşısı yapılması yeterlidir.
B) Tedavi vermeye gerek yoktur, 1. ayda kontrol testleri yapılır.
C) Yalnızca hepatit B immünglobulin (HBIG) verilmelidir.
D) Bebek ilk 6 ay doğrudan antiviral oral tedaviye alınır.
E) Doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde hepatit B aşısı ve HBIG birlikte yapılmalıdır.

24. Febril nötropenik bir hastada geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine rağmen ateşin 72 saat boyunca düşmemesi ve odağın bulunamaması durumunda en uygun yaklaşım ne olmalıdır?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Mevcut antibiyotik tedavisi kesilip hasta takibe alınmalıdır.
B) Empirik sistemik antifungal tedavi eklenmelidir.
C) Yalnızca ateş düşürücü verilerek 48 saat beklenmelidir.
D) Antibiyotik dozu yarıya indirilmelidir.
E) Oral antiviraller başlanıp taburcu edilmelidir.

25. Gonokoksik üretrit ve komplike olmayan gonore tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Chlamydia enfeksiyonu riski nedeniyle kombinasyon tedavisi tercih edilebilir.
B) Enfekte hastanın cinsel partnerinin tedavisine gerek yoktur.
C) Kinolon grubu antibiyotiklere yüksek direnç oranları bildirilebilmektedir.
D) Tek doz azitromisin veya doksisiklin tedaviye eklenebilir.
E) Tek doz IM seftriakson tedavisi önerilen birinci basamak seçeneklerdendir.

26. Akut prostatit tanısı ve yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Şiddetli bakteriyemi/sepsis riski nedeniyle sert rektal muayene ve prostat masajından kaçınılmalıdır.
B) Tedavide penisilin V ilk seçenektir.
C) Hastalarda idrar yapma zorluğu ve ateş hiçbir zaman izlenmez.
D) Tanı için prostat biyopsisi rutin olarak uygulanmalıdır.
E) Yalnızca cerrahi olarak prostatın çıkarılmasıyla iyileşir.

27. Gebelikte Toxoplasma gondii enfeksiyonu, tanısı ve korunma önlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Anti-Toxoplasma IgM pozitifliği akut primer enfeksiyon tanısı için her zaman yeterlidir.
B) Gebenin kediyle temas etmemesi, çiğ et yememesi korunmada önemlidir.
C) IgG avidite testinde yüksek avidite saptanması, enfeksiyonun son 3-4 ay içinde geçirildiğini gösterir.
D) Gebeliğin son aylarında fetüse bulaşma riski azalır.
E) Konjenital toksoplazmozis riski ilk trimesterde en düşük orandadır.

28 · toplanmadı

29. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bir prion hastalığı değildir?

A) Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD)
B) Kuru
C) Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
D) Fatal familial insomnia
E) Alzheimer hastalığı

Not Grupta hatırlanan şıklar: Creutzfeldt-Jakob, kuru, deli dana hastalığı, ailesel ölümcül uykusuzluk.

30 · toplanmadı

31. Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Toplum kaynaklı komplike olmayan ÜSE'de en sık etken E. coli'dir ve çoğunlukla asendan yolla bulaşır.
B) Böbreğe ulaşan enfeksiyonlar her zaman hematojen yolla yayılır.
C) Semptomsuz olan tüm hastalara antibiyotik başlanmalıdır.
D) Üreaz pozitif bakteriler idrar pH'sını asidifiye eder.
E) İdrarda tek bir lökosit görülmesi kesin piyelonefrit tanısı koydurur.

32. 28 yaşında kadın hasta 2 gündür yanma, ateş, sağ yan ağrısı ile başvuruyor. Fizik muayenede ateş 38,8 °C, sağ KVAH+ saptanıyor. Piyüri ve nitrit pozitif. Piyelonefrit tablosunda doku penetrasyonu yetersizliği nedeniyle tercih edilmeyen antibiyotik hangisidir?

A) Siprofloksasin
B) Seftriakson
C) Fosfomisin (tek doz)
D) Trimetoprim-sulfametoksazol
E) Levofloksasin

Not E şıkkı grupta levofloksasin olarak düzeltildi (iki öğrenci).

33. Hücresel immün yetmezliği (T lenfosit defekti) olan bir bireyde aşağıdaki fırsatçı mikroorganizmalardan hangisine bağlı enfeksiyon gelişme riski belirgin şekilde artar?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Haemophilus influenzae
C) Toxoplasma gondii
D) Neisseria meningitidis
E) Streptococcus pyogenes

34 · toplanmadı

Patoloji

Soru 35–68
31/34 toplandı

35. Oil Red O ile nötral lipitleri güvenle göstermek için uygun yaklaşım hangisidir?

A) Doku rutin formalin tespiti sonrası parafine gömülmelidir.
B) Taze/dondurulmuş (frozen) kesit alınıp tespit işlemi ksilol kullanılmadan yapılmalıdır.
C) Dokular alkol serilerinden geçirilip dehidrate edilmelidir.
D) Yüksek ısıda otoklavlanmalıdır.

Not Şık eksik: 4 şık toplandı. Grupta "dondurulmuş kesit soru kökünde değil şıktaydı ve cevap oydu", "parafinle ilgili 3 şık ve gümüş boyama vardı" denildi.

36. Dokularda gelişen nekroz tipleri ve organ eşleşmeleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi en tipik patognomonik/karakteristik eşleşmedir?

A) Beyin enfarktı - likefaksiyon nekrozu; Kalp enfarktı - koagülatif nekroz
B) Akciğer enfarktı - fibrinoid nekroz; Karaciğer - yağ nekrozu
C) Beyin enfarktı - koagülatif nekroz; Dalak - gangrenöz nekroz
D) Mide enfarktı - kazeöz nekroz; Böbrek - likefaksiyon nekrozu
E) Pankreas - koagülatif nekroz; Beyin - kazeöz nekroz

37. Hücrede ROS artışı kronikleşirse hangi iki süreç öne çıkar?
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Lipit peroksidasyonu ile distrofik kalsifikasyon; protein hasarı ile amiloidoz
B) ATP üretiminin artması ile hipertrofi; DNA onarımının artması ile rejenerasyon
C) DNA hasarı ile kanser; protein ve lipit hasarı ile hücresel yaşlanma
D) Antioksidan artışı ile atrofi; lipit birikimi ile yağlanma
E) Katalaz artışı ile apoptoz; süperoksit dismutaz artışı ile nekroz

Not Doğru şık (C) gruptan; diğer şıklar ders notundan üretildi (08 Hücresel yaşlanma: ROS hedefleri lipit, protein ve DNA; sonuç mutasyon ve yaşlanmanın hızlanması); asıl sınav şıkları değildir.

38. Patolojik hiperplazi ve neoplazi süreçleri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hiperplazide uyarı kesilse dahi hücre çoğalması kontrolsüz devam eder.
B) Hiperplazi fizyolojik/patolojik uyaranla gelişir; uyarı kesilince büyüme durabilir ancak patolojik hiperplazi neoplaziye zemin hazırlayabilir.
C) Neoplazi tamamen geri dönüşümlü bir süreçtir.
D) Hiperplazi sadece malign tümörlerde görülür.
E) Hiperplazide hücre sayısı sabit kalır.

39. Kanser hücrelerinde telomeraz enziminin reaktivasyonu ve yüksek aktivitesinin temel patogenetik önemi nedir?

A) Hücrenin apoptoza girmesini doğrudan tetikler.
B) Hayflick sınırının aşılmasını sağlar, telomer boyunu koruyarak hücreye sonsuz bölünme yeteneği kazandırır.
C) DNA replikasyonunu tamamen durdurur.
D) Hücre dışı matris yıkımını engeller.
E) Tümör hücresinin immün sistem tarafından tanınmasını sağlar.

40. Fibrinöz perikarditte çözünmeyen (temizlenemeyen) fibrin için beklenen sonuç nedir?
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Organizasyon ile fibrozis ve yapışıklık gelişir
B) Apse oluşur
C) İz bırakmadan tam rezolüsyon olur
D) Ülserasyon gelişir
E) Kazeifikasyon nekrozu gelişir

Not Şıklar ders notundan üretildi (09 Akut enflamasyon: fibrinöz eksüda fibrinolizle çözünür, çözünmezse organizasyon → fibrozis ve yapışıklık); asıl sınav şıkları değildir.

41. Komplement sisteminin alternatif ve lektin yolu için doğru tetikleyici çifti hangisidir?
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Alternatif: antijen-antikor kompleksi; Lektin: mannoz bağlayıcı lektin
B) Alternatif: mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS, polisakkaritler); Lektin: mannoz bağlayıcı lektinin mikrobiyal karbonhidratlara bağlanması
C) Alternatif: C1 inhibitörü; Lektin: IgM
D) Alternatif: mannoz bağlayıcı lektin; Lektin: LPS
E) Alternatif: IgG; Lektin: IgE

Not Şıklar ders notundan üretildi (12 Kimyasal mediyatörler, kompleman aktivasyon yolları tablosu); asıl sınav şıkları değildir.

42. Kronik enflamasyonun morfolojik özellikleri için en doğru kombinasyon hangisidir?
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Ödem + nötrofil infiltrasyonu + tam iyileşme
B) Mononükleer hücre infiltrasyonu + doku yıkımı + onarım girişimleri (anjiyogenez, fibrozis)
C) Fibrinöz eksüda + nötrofil + apse
D) Eozinofil + mast hücresi + vazodilatasyon
E) Seröz eksüda + nötrofil + rezolüsyon

Not Doğru şık gruptan; diğer şıklar ders notundan üretildi (13 Kronik enflamasyon: morfolojik özellikler ve akut-kronik karşılaştırması); asıl sınav şıkları değildir.

43. Sekonder yara iyileşmesinde en tipik özellik nedir?
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Az skar ve minimal kontraksiyon
B) Daha fazla granülasyon dokusu, belirgin skar ve belirgin kontraksiyon
C) Kenarları yaklaştırılmış temiz kesi ile iyileşme
D) Enfeksiyon riski nedeniyle önce açık bırakılıp sonra kapatılma
E) Skarın yara sınırlarının dışına taşması

Not Gruptan "az skar..." şıkkı hatırlandı (A, primer iyileşme özelliği). Diğer şıklar ders notundan üretildi (15 Yara iyileşmesi: primer, sekonder, tersiyer iyileşme tablosu); asıl sınav şıkları değildir.

44. Kronik pulmoner konjesyonda en olası histolojik kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alveol septasında incelme + lenfatik genişleme
B) Alveol septasında fibrozis + hemosiderin makrofajı
C) Bronşiolde metaplazi + kazeifikasyon
D) Kapiller damarda trombus + koagülasyon nekrozu
E) Yaygın amiloid birikim + granülom oluşumu

45. Ülserleşmiş aterosklerotik plak üzerinde gelişen arteriyel tromboz için Virchow üçlüsünün en uygun bileşenleri hangisidir?

[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Staz + laminer akım
B) Hiperkoagülabilite + endotel hasarı + staz
C) Endotel hasarı + türbülanslı (anormal) kan akımı
D) Hiperkoagülabilite + staz
E) Laminer akım + hiperkoagülabilite

Not A ve B gruptan hatırlandı. Diğer şıklar ders notundan üretildi (20 Tromboz: arteriyel trombüste endotel hasarı ön koşul, türbülans örneği ülserleşmiş aterosklerotik plak); asıl sınav şıkları değildir.

46. Septik şok seyrinde adrenal yetmezlik gelişmesi hangi sendrom ile ilişkilendirilir?

A) Waterhouse-Friderichsen sendromu
B) Goodpasture sendromu
C) Cushing sendromu
D) Conn sendromu
E) Addison hastalığı

47. Tip IV (gecikmiş tip) aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?

A) Dolaşan immün komplekslerin dokularda birikmesiyle gelişir.
B) Mast hücreleri ve IgE antikorları aracılığıyla gelişir.
C) T lenfositler (CD4+ ve CD8+) aracılıdır, antikorların doğrudan rolü yoktur veya azdır.
D) Sadece IgG veya IgM sınıfı antikorlar rol oynar.
E) Komplement sisteminin doğrudan aktivasyonu ile saniyeler içinde gelişir.

Not E şıkkı grupta hatırlanmadı. Grupta "lineer IgG iki soruda da şık olarak geçiyordu" denildi.

48. Marfan sendromlu hastalarda doku elastik lif yapısındaki bozukluğa bağlı olarak en sık görülen ve hayati tehdit oluşturan kardiyovasküler komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pulmoner kapak stenozu
B) Mitral kapak kalsifikasyonu
C) Triküspit yetmezliği
D) Koroner arter aterosklerozu
E) Aort anevrizması ve aort diseksiyonu

49. Kurşun maruziyeti olan erişkinlerde en tipik nörolojik bulgu hangisidir?

[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Düşük IQ, davranış bozukluğu ve nöbet
B) Periferik nöropati; bilek ve ayak düşmesi
C) Parkinsonizm ve istemsiz hareketler
D) Optik nörit ve görme kaybı
E) Ataksi ve nistagmus

Not Grupta "çocuk ve erişkin bulguları ayrı şıklardaydı" denildi (A çocuk bulgusu). Diğer şıklar ders notundan üretildi (26 Çevresel patoloji: kurşun, sinir sistemi bulguları); asıl sınav şıkları değildir.

50. Diyabetik nefropatinin patognomonik ve en karakterize histopatolojik nodüler glomerüler nodül bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Kimmelstiel-Wilson nodülleri
B) Libman-Sacks lezyonları
C) Flea-bitten böbrek
D) Wire-loop lezyonu
E) Crescentic glomerülorefleks

51. Aşağıdaki klinik tümör kümelenmelerinden hangisi Li-Fraumeni sendromu (TP53 mutasyonu) ile en uyumludur?

A) Yumuşak doku sarkomu, osteosarkom, meme kanseri, beyin tümörleri ve adrenokortikal karsinom
B) Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma, paratiroid hiperplazisi
C) Kolon polipleri, osteomlar, epidermoid kistler
D) Renal hücreli karsinom, hemanjiyoblastom, feokromositoma
E) Bilateral akustik nörinom, meningiom, şvannom

52. SLE nedeniyle uzun süreli hidroksiklorokin (Plaquenil) kullanan bir hastanın organ toksisitesi takibinde rutin olarak hangi muayenenin yapılması gereklidir?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Oftalmolojik (göz dibi / retina) muayene
B) Odyolojik muayene
C) Açık akciğer biyopsisi
D) Kemik iliği aspirasyonu
E) Günlük troponin ölçümü

Not Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi (birkaçından emin değiller).

53. Apoptoz (programlanmış hücre ölümü) mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Hücre büzülmesi ve kromatin kondansasyonu izlenir.
B) Hücre zarı bütünlüğü korunur, belirgin inflamasyon oluşturmaz.
C) Ana yürütücü (executioner) kaspaz kaspaz-3'tür; kaspaz-8 ve 9 ise başlatıcıdır.
D) DNA 180-200 bp oligonükleozomal fragmanlara bölünür.
E) BCL-2 ailesi proteinleri apoptoz regülasyonunda rol almaz.

54. Minimal Değişim Hastalığı (Minimal Change Disease) patolojisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Proksimal tübülde kresent birikimi
B) Proksimal tübülde kalsifikasyon birikimi
C) Proksimal tübülde protein damlacıkları ve lipit birikimi
D) Proksimal tübülde IgG birikimi
E) Çizgisel (lineer) IgG birikimi

Not Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi; E şıkkı kısmen hatırlandı.

55. Aşağıdakilerden hangisi nefritik sendrom klinik tablosunun tipik bulgularından biridir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Masif proteinüri (>3,5 g/gün) ve belirgin lipidüri
B) İzole hiperlipidemi ve ksantomlar
C) İzole glukozüri ve ketonüri
D) Hematüri, oligüri, hipertansiyon ve eritrosit silendirleri
E) İzole hipokalsemi ve tetani

56. İntrasellüler ROS artışı ve DNA hasarında apoptozun mitokondriyal (intrinsik) yolağında gerçekleşen olayların doğru sırası hangisidir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Sitokrom-c salınımı → BAX/BAK aktivasyonu → Kaspaz-3
B) BAX/BAK oligomerizasyonu → zar geçirgenlik artışı → sitokrom-c'nin sitozole salınımı → kaspaz aktivasyonu
C) Kaspaz-3 aktivasyonu → sitokrom-c → DNA kırılması
D) TNF reseptör bağlanması → kaspaz-8 → BAX baskılanması
E) Bcl-2 artışı → mitokondri patlaması → nekroz

57. Akut piyelonefrit tanısında böbrek histopatolojisinde görülen en tipik mikroskobik bulgu nedir?

A) Tübüluslarda ve interstisyel alanda nötrofil lökosit infiltrasyonu ile tübüler nekroz ve lökosit silendirleri
B) Glomerüllerde mezanjiyal amiloid birikimi
C) Bowman kapsülünde kresent oluşumu
D) Arteriyollerde hiyalin kalınlaşma
E) İnterstisyel alanda yoğun eozinofil birikimi

58. Endokrin organ tümörlerinde hormon üretimi ve fonksiyonel aktivite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Malign ve anaplastik tümörler her zaman en yüksek hormonu salgılar.
B) İyi diferansiye benign tümörlerde hormon üretimi ve salgılanması normal endokrin yapıya daha uygundur.
C) Tümörün diferansiyasyonu düştükçe hormon sentez kapasitesi artar.
D) Adenomlar hiçbir zaman hormon salgılayamaz.
E) Hormon üretimi sadece metastatik lezyonlarda gerçekleşir.

59. Renal hücreli karsinomun (RCC) en sık görülen 3 histolojik/moleküler alt tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Onkositoma, Wilms, anjiyomiyolipom
B) Berrak hücreli (clear cell), papiller, kromofob
C) Papiller, Wilms, kromofob
D) Berrak hücreli, onkositoma, kromofob
E) Kromofob, anjiyomiyolipom, berrak hücreli

60. Genital Herpes Simplex Virüs (HSV) enfeksiyonunun doku histopatolojisindeki en tipik sitopatolojik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dokuda koilositoz ve belirgin perinükleer halo
B) Cowdry A tipi intranükleer inklüzyonlar, multinükleasyon ve nükleer marjinasyon
C) Obliteratif/proliferatif endarterit
D) Nekrotizan granülom ile oluşan yıldızsı apse
E) Lamina propria içinde lenfoid folikül

61. Candida vulvovajiniti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tipik olarak kaşıntı ve peynirimsi beyaz akıntı ile seyreder.
B) Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak sınıflandırılmaz; fırsatçıdır.
C) Antibiyotik kullanımı ve diyabet riski artırır.
D) Mikroskopide psödohif ve tomurcuklanan maya hücreleri izlenebilir.
E) Bulaşması esas olarak siprofloksasin kullanımı ile tamamen engellenir.

Not Grupta şıklarda hem "cinsel yolla bulaşır" hem "cinsel yolla bulaşmaz" ifadesi olduğu hatırlandı; diğer şıklar kesin değil.

62 · toplanmadı

63. Endometriyum hiperplazisini en iyi tanımlayan sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?

A) LSIL / HSIL
B) Seröz / berrak hücreli
C) Atipili / atipisiz
D) Kronik / akut
E) Papiller / kromofob

Not Şıklar gruptaki öğrenci sürümünden.

64. Bilateral over tutulumu gösteren müsinöz tümörde öncelikle düşünülmesi gereken tanı aşağıdakilerden hangisidir?
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Müsinöz kistadenom
B) Seröz kistadenom
C) Krukenberg tümörü
D) Brenner tümörü
E) Matür kistik teratom

Not Grupta yalnız 64. soru için ders slaytı paylaşıldı ("bilateralite önemli ipucu"). Kök ve şıklar ders notundan üretildi (55 Over tümörleri: müsinöz tümörlerin bilateral olma olasılığı düşük; Krukenberg GİS kökenli, sıklıkla bilateral); asıl sınav şıkları değildir.

65–66 · toplanmadı

67. Aşağıdakilerden hangisi meme başının Paget hastalığı için doğrudur?
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Olguların tamamına yakınında altta karsinom bulunur ve bunların yaklaşık yarısı invazivdir
B) Genellikle bilateraldir
C) Prognoz Paget hastalığının varlığına göre belirlenir
D) Altta yatan karsinom nadiren bulunur
E) Benign bir dermatozdur, malignite ile ilişkisi yoktur

Not Doğru ifade gruptan. Diğer şıklar ders notundan üretildi (65 Meme kanseri: Paget hastalığı unilateral, altta ~%50 invaziv karsinom, prognoz alttaki karsinoma bağlı); asıl sınav şıkları değildir.

68. Prostat adenokarsinomunu histolojik olarak BPH veya benign bezlerden ayıran en önemli histopatolojik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prostat bezlerindeki dış bazal hücre (miyoepitelyal) tabakasının kaybolması
B) Bezlerde korpora amilasea bulunması
C) Stromada lenfosit birikimi
D) Bez boyutlarının aşırı büyümeli olması
E) Bezlerin tek katlı silindirik epitelle döşeli olması

Halk Sağlığı

Soru 69–78
9/10 toplandı

69. Anne sütü ve bebek beslenmesi ile ilgili öncüllerden hangileri doğrudur?
I. İlk 6 ayda besin gereksiniminin %90'ını karşılar.
II. TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 1,42'dir.
III. Yalnız anne sütüyle beslenen bebekte demirin emilimi %50-60'tır.
IV. Yeterli beslenen annenin sütü D vitamini dışındaki tüm vitamin ihtiyacını karşılar.
[ŞIKLAR ÜRETİLDİ] [TARTIŞMALI]

A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Not Tartışmalı. Öncüller gruptan (I, II, III kesin; IV "C/D hariç bütün vitaminler" diye hatırlandı), şıklar ders notundan üretildi. 22 Bebek beslenmesi: anne sütü ilk 6 ayda gereksinimin %100'ünü karşılar (I yanlış), demir emilimi %50-60, D vitamini dışındaki vitaminler karşılanır. II ders notunda yok; öğrenciler doğru diye hatırladı.

70. Türkiye'de çağdaş halk sağlığı biliminin kurucusu kabul edilen, 224 Sayılı Sosyalleştirme Kanunu'nu hazırlayan bilim insanı kimdir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Prof. Dr. Nusret Fişek
B) Dr. Refik Saydam
C) Dr. Behçet Uz
D) Prof. Dr. Mazhar Osman
E) Dr. Hulusi Behçet

71. Bulaşıcı hastalıkların ve çevresel toplum sağlığı risklerinin önlenmesinde hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetidir?
[YERİ TAHMİNİ] [TARTIŞMALI]

A) Besin kontrolü / beslenme değişikliği
B) Kemoprofilaksi
C) Bağışıklama
D) Hijyen
E) Sağlık eğitimi

Not Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi. Cevap tartışmalı: grupta "hijyen mi?" diye soruldu, kesinleşmedi. Bağışıklama ve kemoprofilaksi kişiye yönelik hizmetlerdir.

72. Gebelik takibinde tüm gebelere rutin önerilen ve gebelikte güvenle uygulanabilen aşı aşağıdakilerden hangisidir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Kızamıkçık (rubella) aşısı
B) Suçiçeği aşısı
C) Tetanoz (Td/Tdap) aşısı
D) Kızamık aşısı
E) BCG (verem) aşısı

73. Aşağıdakilerden hangileri sekonder korunma yöntemidir?
I. Halk sağlığı merkezlerinde verilen hijyen eğitimi
II. Mamografi
III. Bir ailenin çocuklarının ne zaman doğacağını planlaması
IV. Pap smear
[YERİ TAHMİNİ]

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) Yalnız IV
E) III ve IV

Not Grupta 24.10 eklendi. II. öncülün mamografi mi bağışıklama mı olduğu tartışıldı, çoğunluk mamografi dedi. Kökün "yöntemidir" olduğu hatırlandı.

74. Terminde ve 2,5 kg doğan bebeğin 6. ay ve 1. yaştaki beklenen ortalama ağırlıkları hangisinde doğru verilmiştir?

A) 6. ay: 3,5 kg / 1. yaş: 5 kg
B) 6. ay: 5 kg / 1. yaş: 7,5 kg
C) 6. ay: 7,5 kg / 1. yaş: 10 kg
D) 6. ay: 9 kg / 1. yaş: 12 kg
E) 6. ay: 4 kg / 1. yaş: 6 kg

Not Derleme PDF'inin anahtarı C diyor; grupta da paylaşılan ders notuna göre bebekler 4–6 ayda doğum ağırlığının 2, bir yaşında 3 katına ulaşır → B (5 / 7,5 kg).

75. Korunma düzeyleri ile ilgili öncüllerden hangileri doğrudur?
I. İstediği zaman çocuk sahibi olmak için aile planlaması yapan çift tersiyer korunma uygulamaktadır.
II. Okullarda çocuklara yapılan görme taraması ikincil korunmadır.
III. Aşılama birincil korunmadır.
IV. Diyabetik hastada ayak amputasyonunun önlenmesi ikincil korunmadır.
[YERİ TAHMİNİ] [ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve III

Not I ve II gruptan hatırlandı; III, IV ve şıklar ders notundan üretildi (18 Halk sağlığı tarihçesi: korunma düzeyleri tablosu); asıl sınav şıkları değildir. Aile planlaması birincil korunmadır (gebelik/doğum komplikasyonlarını önleme).

76. Güncel Sağlık Bakanlığı rehberine göre sağlıklı bir gebe, gebelik boyunca en az kaç kez izlenmelidir?
[YERİ TAHMİNİ] [ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 13

Not Cevap (4) gruptan. Diğer şıklar ders notundan üretildi (23 Ana-çocuk sağlığı: 224 sayılı kanun 13 kez, 2001 yönergesi 6 kez, 2009 ve güncel 4 kez); asıl sınav şıkları değildir.

77 · toplanmadı

78. Anne sütünde bulunmayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alfa-laktalbümin
B) Laktoferrin
C) Beta-laktoglobulin
D) Sekretuar IgA
E) Kazein

Üroloji

Soru 79–90
11/12 toplandı

79. Akut komplike olmayan sistit vakalarında aşağıdaki klinik bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Dizüri (idrar yaparken yanma)
B) Pollaküri (sık idrara çıkma)
C) Yüksek ateş ve titreme
D) Sıkışma (urgency) hissi
E) Suprapubik ağrı

80. Enürezis nokturnası olan 7 yaşında erkek çocukta birinci basamak medikal tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bekle-gör yaklaşımı
B) Üroterapi
C) Desmopressin
D) Antidepresan
E) Antikolinerjik

Not Kök ve şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi ("davranışsal tedaviye yanıt yok" ifadesi kökte yoktu).

81. Aşağıdaki patolojik durumlardan hangisi prerenal proteinüri (overflow/taşma proteinürisi) nedenleri arasında yer alır?

A) Glomerülonefrit
B) Multipl miyelom (Bence-Jones proteinürisi)
C) Diyabetik nefropati
D) Polikistik böbrek hastalığı
E) Alt üriner sistem enfeksiyonu

Not Grupta şıklar "gebelik, glomerülonefrit, nefritik sendrom..." diye de hatırlandı; şıklar kesin değil.

82. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem taş hastalığı (ürolitiyazis) gelişiminde bir risk faktörü değildir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) Yetersiz (az) sıvı alımı
B) Hiperkalsiüri
C) Yüksek oranda hayvansal protein ve tuz tüketimi
D) Yeterli su tüketimi
E) Sıcak iklimde yaşamak

83. Suprapubik aspirasyon ile elde edilen idrar kültüründe anlamlı enfeksiyon tanısı için en az kaç CFU/mL bakteri yeterlidir?
[YERİ TAHMİNİ] [TARTIŞMALI]

A) 10^5
B) 10^4
C) 10^3
D) 10^7
E) 10^6

Not Tartışmalı: ders slaytında suprapubik aspirasyonda "herhangi bir sayıda gram(-) basil, ≥10^3 gram(+) kok" yazıyor; bir öğrenci "bakteri bulunması anlamlıdır" diye itiraz önerdi.

84. Enürezis nokturna için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
[YERİ TAHMİNİ]

A) 3 yaşın üzerindeki çocuklar tedavi gerektirir.
B) Yıllık spontan rezolüsyon oranı yaklaşık %15'tir.
C) Hastalığın patogenezinde genetik de yer alır.
D) Uyanma güçlüğü sıklıkla eşlik eder.
E) Enürezis sıklığı arttıkça spontan rezolüsyon oranı azalır.

Not Grupta 24.10 eklendi; tedavi 5 yaşından sonra düşünülür. Şıklardan emin değiller.

85. Aşağıdaki obstrüktif üropati nedenlerinden hangisi infravezikal (mesane altı) obstrüksiyon nedenidir?

A) Renal kist
B) Posterior üretral valv (PUV)
C) Gebeliğe bağlı üretere bası
D) Nefrolitiyazis
E) Renal arter anevrizması

Not Bir öğrenci D şıkkını "fimozis" olarak hatırladı; öyleyse o da infravezikaldir, şıklar kesin değil.

86. Alt üriner sistem obstrüksiyonlarında mesanenin kompansasyon evresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Detrüsör kası hipertrofiye uğrar ve işeme basıncını artırarak mesanede rezidüel idrar kalmamasını sağlar.
B) Mesane kası tamamen atoniktir.
C) İşeme sonrası yüksek miktarda glob vezikale oluşur.
D) Böbrek yetmezliği hemen gelişir.
E) Detrüsör kası incelir ve atrofiye uğrar.

87. İdrar örneği alma yöntemleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orta akım idrarı rutin kültür için en sık kullanılan yöntemdir.
B) Suprapubik aspirasyon kontaminasyona en açık ve güvenilmez idrar alma yöntemidir.
C) Sondalı hastalarda idrar kateterin özel steril portundan alınmalıdır.
D) Bebeklerde idrar torbası örneklerinde üremede konfirmasyon gerekebilir.
E) Suprapubik aspirasyon invaziv bir yöntemdir.

88. Üriner sistem enfeksiyonlarının tanımları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
[TARTIŞMALI]

A) Rekürren enfeksiyonlar, iyi bir tedavinin ardından genellikle iki haftadan az sürede aynı patojenle gerçekleşen üriner sistem enfeksiyonlarıdır.
B) Re-enfeksiyon, geçirilmiş bir enfeksiyonun ardından farklı bir patojenle tekrar enfekte olmaktır.
C) Bakteriyel persistans, üriner sistemde yerleşmiş patojenlerin yaptığı rekürren enfeksiyonlardır.
D) Nozokomiyal (hastane kaynaklı) enfeksiyonlar tipik olarak Pseudomonas veya dirençli suşların yaptığı enfeksiyonlardır.
E) Anatomik ya da yapısal anomalisi bulunmayan hastalardaki üriner sistem enfeksiyonlarına komplike üriner sistem enfeksiyonu denir.

Not Beş şık gruptaki öğrenci sürümünden. E kesin yanlış (bu tanım komplike olmayan ÜSE'dir). Derleme PDF'i A'yı işaretlemişti; A aslında relapsın tanımıdır, tartışmalı.

89. Aşağıdakilerden hangisi alt üriner sistemin depolama (dolum) semptom veya fonksiyonlarından biri değildir?

A) Noktüri
B) Sıkışma
C) Aralıklı akım
D) Pollaküri
E) Sıkışma tipi idrar kaçırma

90 · toplanmadı

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Soru 91–96
6/6 toplandı

91. G2P1 gebede USG'de serviks açık, intrauterin servikse yakın yerleşimli, düzensiz görünümde gestasyonel kese izlenirken embriyo/kalp atımı izlenmiyor. Kanama ve krampları olan bu hastada en olası düşük tanısı nedir?

A) Abortus imminens (düşük tehdidi)
B) Komplet abortus
C) İnkomplet abortus (tam olmayan düşük)
D) Tekrarlayan gebelik kaybı
E) Missed abortus

92. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte fetal kromozom anomalilerinin kesin tanısı amacıyla uygulanan invaziv (girişimsel) testlerden biridir?
[YERİ TAHMİNİ]

A) İkili tarama testi
B) Üçlü tarama testi
C) Koryon villus biyopsisi (CVS)
D) Entegre tarama testi
E) Ultrasonografik ense kalınlığı (NT) ölçümü

Not Grupta 24.10 eklendi. Kökün "biridir" olduğu hatırlandı; dörtlü test şıklarda yoktu, entegre test vardı, CVS ya da kordosentez şıklardaydı.

93. Toplam 4 kez gebe kalmış, 36. ve 38. haftalarda 2 canlı çocuk doğurmuş (biri vajinal, biri sezaryen), 16. ve 25. haftalarda 2 kez düşük yapmış kadının G P Y A değeri nedir?

A) G4 P2 Y2 A2
B) G4 P4 Y2 A0
C) G2 P2 Y2 A2
D) G4 P3 Y2 A1
E) G3 P2 Y1 A1

Not 20. haftayı geçen 25. hafta kaybı doğum (parite) sayılır, 16. hafta kaybı abortus.

94. Perinatolojide fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde kullanılan aşağıdaki testlerden hangisi bir fetal iyilik hali değerlendirme testi değildir?

A) Non-stres test (NST)
B) Biyofizik profil (BPP)
C) Kontraksiyon stres testi (CST)
D) Fetal umbilikal arter Doppler ultrasonografi
E) Doppler ile fetal renal arter incelemesi

Not Grupta cevap "Doppler ile renal arter incelemesi" olarak hatırlandı; şıkların geri kalanı kesin değil. Derleme PDF'inde E "maternal serum AFP" idi.

95. Spontan düşükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

[YERİ TAHMİNİ] [ŞIKLAR ÜRETİLDİ]

A) Düşük doz (<5 rad) radyasyon maruziyeti düşüğe neden olur.
B) Abort materyalinde en sık görülen trizomi, trizomi 21'dir.
C) Spontan düşüklerin %80'i ilk trimesterde görülür.
D) Kromozomal anomali oranı ikinci trimesterde birinci trimesterden yüksektir.
E) Trizomi 1, 3 ve 19 abort materyallerinde en sık görülen trizomilerdir.

Not A ve B ifadeleri gruptan hatırlandı. Diğer şıklar ders notundan üretildi (61 Abortus: radyasyon >5 rad, trizomilerden en sık trizomi 16, düşüklerin %80'i ilk trimester, kromozomal oran 1. trimester %70 / 2. trimester %30); asıl sınav şıkları değildir.

96. Grafik/tablo üzerinden sorulan fetal izlem sorusu.

[YERİ TAHMİNİ] [KISMİ]

Şıklar toplanmadı.

Not Kısmi: grupta "kadın doğumdaki grafik sorusuna itiraz edecek miyiz" diye konuşuldu, cevap için "non-stres test" denildi; kök ve şıklar toplanmadı.

Farmakoloji

Soru 97–100
3/4 toplandı

97. Böbrek nakli yapılan hastada T lenfosit aktivasyonunu baskılamak için başlanan takrolimusun temel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) mTOR proteinini inhibe ederek IL-2 yanıtını engellemek
B) Dihidrofolat redüktazı inhibe ederek DNA sentezini bozmak
C) Kalsinörini inhibe ederek IL-2 gen transkripsiyonunu engellemek
D) IL-2 reseptörünün alfa alt birimini (CD25) bloke etmek
E) İnozin monofosfat dehidrojenaz enzimini inhibe etmek

98. Gebelerde kullanımı sırasında ağır teratojenite (fokomeli / ekstremite yokluğu) yol açtığı için gebelikte kullanımı kesinlikle kontrendike olan tarihî ilaç hangisidir?

[YERİ TAHMİNİ]

A) Talidomid
B) Penisilin
C) Parasetamol
D) Folik asit
E) İnsülin

99 · toplanmadı

100. Kemik rezorpsiyonunu engellemek amacıyla kullanılan, RANKL'a karşı geliştirilmiş monoklonal antikor ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denosumab
B) Siklosporin
C) Metotreksat
D) İnfliksimab
E) Bevasizumab

Cevap anahtarı

“*”: şıklar ders notundan üretildi. “kısmi”: şıklar toplanmadı. “—”: soru toplanmadı. Numaraları tahmini olan soruların yeri ders içinde değişebilir.

Tıbbi Genetik 1–12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	D	D	A	B	A	D	E	A
11	12								
D	B								

Enfeksiyon Hastalıkları 13–34

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
B	D	C	C	C	C	C	A	A	D
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
E	B	B	A	B	—	E	—	A	C
33	34								
C	—								

Patoloji 35–68

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
B	A	C*	B	B	A*	B*	B*	B*	B
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
C*	A	C	E	B*	A	A	A	E	C
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
D	B	A	B	B	B	E	—	C	C*
65	66	67	68						
—	—	A*	A						

Halk Sağlığı 69–78

69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
D*	A	D	C	C	B	C*	B*	—	C

Üroloji 79–90

79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
C	C	B	D	C	A	B	A	B	E
89	90								
C	—								

Kadın Hastalıkları ve Doğum 91–96

91	92	93	94	95	96				
C	C	D	E	C*	kısmi				

Farmakoloji 97–100

97	98	99	100						
C	A	—	A						